



BÓL DOLNEJ CZĘŚCI PLECÓW

Czym jest i jak sobie radzić

Większość z nas doświadczy bólu dolnej części pleców (LBP) w pewnym momencie swojego życia. Czasami może być bardzo bolesny i może mieć znaczący wpływ na naszą jakość życia i aktywność. Jednak dobrą wiadomością jest to, że chociaż może być niewygodny i frustrujący, jest bardzo powszechny, a rokowanie jest korzystne.

Większość LBP (Low back pain = ból dolnej części pleców) nie jest groźna i mało prawdopodobne, aby była spowodowana poważną patologią, często ustępując samoistnie w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Celem tego artykułu jest dostarczenie Ci wiedzy i zrozumienia, które mogą wesprzeć Cię w trakcie rekonwalescencji i pomóc Ci optymalnie zarządzać Twoim LBP.

Najważniejsze wnioski

- Ból dolnej części pleców (LBP) jest bardzo powszechny
- Może to być frustrujące i mieć wpływ, ale rzadko wiąże się z poważnym urazem lub chorobą
- Z czasem problem zazwyczaj ustąpi przy rehabilitacji
- Bądź aktywny i zaangażowany
- Zadbaj o swoje ogólne samopoczucie
- Pamiętaj, że ból nie oznacza, że coś jest złamane

LBP jest bardzo powszechnym schorzeniem i rzadko wiąże się z poważną patologią

LBP jest często definiowane jako ból, cierpienie i/lub dyskomfort w dolnej części pleców, który czasami może odnosić się do pośladka i/lub nogi. Większość z nas doświadczy LBP w pewnym momencie swojego życia (ryc. 1), a tak naprawdę wielu z nas będzie doświadczać nawracających epizodów z wahaniami objawów. Epizody LBP stają się częstsze wraz z wiekiem, ale mogą również dotyczyć dzieci i nastolatków.



Rycina 1. U 80% osób w pewnym momencie życia wystąpi ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa.

- ♥ U wielu osób wielokrotne epizody LBP zdarzają się regularnie, ale jest to normalne i zazwyczaj nie ma powodu do obaw.

Co jest przyczyną mojego LBP?

Większość epizodów LBP nie jest spowodowana poważną patologią. Mniej niż 1% przypadków jest spowodowane czymś poważniejszym, np. złamaniem lub nowotworem (ryc. 2).

Tak zwane „czerwone flagi” mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób z potencjalnie poważnymi patologiami, które wymagają dalszych badań. Twój fizjoterapeuta sprawdzi, czy masz którykolwiek z tych sygnałów ostrzegawczych i podejmie odpowiednie działania.

Większość przypadków bólu pleców trwa krócej niż 3 miesiące (tzw. ostry ból pleców) i jest najprawdopodobniej spowodowana prostymi „skręceniami lub naciągnięciami”, podobnie jak na przykład skręcenie kostki lub ból kolana, który może wystąpić przy nagłym zwiększeniu aktywności bez wcześniejszego doświadczenia.



Rycina 2. Tylko 1/100 lub mniej ma poważną patologię

W większości przypadków LBP jest definiowane jako „niespecyficzne LBP”, co oznacza, że nie można zidentyfikować pojedynczej konkretnej przyczyny. Kilka struktur w dolnej części pleców może przyczyniać się do bólu, więc często trudno jest wskazać jedną konkretną przyczynę.

Ponadto uraz nie zawsze oznacza, że będziesz odczuwać ból, a ból, nawet jeśli jest silny, nie jest dobrym wskaźnikiem rzeczywistej szkody. Na przykład dwie osoby mogą mieć podobne zmiany w strukturach kręgosłupa, ale tylko jedna odczuwa ból. Dzieje się tak, ponieważ istnieje wiele różnych i często zależnych od czasu czynników fizycznych, psychologicznych i społecznych, które wpływają na to, czy dana osoba odczuje ból i jak sobie z nim radzi. Przeczytaj więcej o bólu w Ramce 1.

Ramka 1. Ból jest nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym.

Działa jako odpowiedź alarmowa tworzona przez układ nerwowy. Twój mózg odbiera różne sygnały pochodzące z ciała, ale także inne informacje, np. Twoje przeszłe doświadczenia, przekonania i emocje itp. Jednak czasami Twój układ nerwowy może podnieść fałszywy alarm, gdy nie ma prawdziwego zagrożenia. Dobrze jest to zrozumieć i uznać, gdy odczuwasz ból pleców, szczególnie jeśli ból utrzymuje się... ale także, gdy odczuwasz ból, który nie trwa długo.

Jako prosty przykład wyobraźmy sobie, że idziesz popływać w morzu i właśnie zostałeś ostrzeżony, że obszar ten jest znanym siedliskiem szkaradnic (bardzo jadowitej ryby). Albo że wcześniej miałeś bliskie i bolesne spotkanie z meduzą. Podczas pływania czujesz, jak coś dotyka twojej nogi i odczuwasz ostry, ostry ból. Szybko odsuwasz nogę i odwracasz się, aby dopłynąć z powrotem w bezpieczne miejsce. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że to twój przyjaciel otarł się o twoją nogę podczas pływania i nie było żadnego realnego niebezpieczeństwa ani urazu, mimo że czułeś ból. Dzieje się tak, ponieważ twój mózg wykorzystuje informacje z wielu źródeł, w tym twoje wcześniejsze doświadczenia i/lub emocje (być może nie czułeś się bezpiecznie po usłyszeniu o rybie!), podczas gdy interpretuje sygnał pochodzący z receptorów w twojej nodze jako „ból”.



Ból nie zawsze oznacza, że tkanki lub struktury kręgosłupa są uszkodzone. Obecność potencjalnych uszkodzeń nie musi również powodować bólu lub szkody.



Intensywność bólu nie jest związana z ciężkością ani istnieniem urazu.



Ból jest reakcją wytwarzaną przez mózg, a nie przez uszkodzoną tkankę.
Wiele czynników może zatem wpływać na reakcję bólową.

Czy potrzebuję obrazowania?

Wykonanie skanu (np. obrazowania, takiego jak MRI) na losowej próbie populacji ogólnej ujawniłoby oznaki zwyrodnienia lub zmiany w dyskach i stawach w kręgosłupie lędźwiowym, nawet u osób bez objawów LBP. Te odkrycia są powszechne, szczególnie gdy się starzejemy, ponieważ jest to część normalnego procesu starzenia, tak jak siwienie włosów i pojawianie się zmarszczek na skórze. Dlatego zazwyczaj nie ma potrzeby obrazowania.

W rzeczywistości znajomość wyników skanu i błędne przypisanie ich do LBP może powodować niepokój i błędne przekonanie, że ból nigdy nie ustąpi, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia uporczywych objawów. Ponadto, nawet jeśli otrzymasz skan, często nie jest on pomocny w określeniu, jak należy leczyć LBP.

Obrazowanie jest właściwe, jeśli występują cechy ostrzegawcze dotyczące konkretnego i/lub poważnego problemu, takiego jak ból po ciężkim urazie, gorączka, utrata wagi, historia nowotworu lub infekcji. Twój fizjoterapeuta sprawdzi, czy występują jakiegokolwiek oznaki poważnej przyczyny i określi, czy skan jest odpowiednim sposobem leczenia dla Ciebie.



Wyniki skanów nie korelują ściśle z bólem.

Wskazówki dotyczące samodzielnego zarządzania LBP

Mimo że istnieje kilka czynników, które mogą przyczyniać się do LBP i że nie zawsze można zidentyfikować jedną przyczynę objawów, istnieje kilka typowych kroków, które możesz podjąć, aby wesprzeć swój własny powrót do zdrowia, złagodzić objawy i poprawić swoją funkcję i jakość życia podczas doświadczania LBP. Takie kroki mogą również pomóc w zmniejszeniu nawrotów po ustąpieniu objawów.



1. Spróbuj pozbyć się niepomocnych i niedokładnych przekonań

Po pierwsze, nauczenie się porzucania błędnych przekonań, które możesz mieć na temat LBP, może być bardzo pomocne w powrocie do zdrowia. Niektóre powszechne i niepomocne przekonania to na przykład „schylanie się i podnoszenie (z zaokrąglonymi plecami) jest szkodliwe”, „ból jest oznaką złamania, uwięzienia, poślizgnięcia lub nieprawidłowego ustawienia czegoś”, „LBP jest spowodowane moim słabym rdzeniem” i „LBP jest spowodowane moją złą postawą”.

Twój fizjo może zasugerować dodatkowe źródła wiedzy wykraczające poza treść tego artykułu. Nie wahaj się zapytać, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.

2. Zachowaj pozytywne nastawienie i zaangażowanie

Ważne jest, aby pozostać pozytywnie nastawionym i zaangażowanym w pracę, codzienne czynności, kontakty społeczne i aktywności, które lubisz. Jeśli odczuwasz silny ból, możesz początkowo musieć zmodyfikować swoje aktywności i/lub dostosować tempo, aby móc pozostać aktywnym. Jest to o wiele lepsze podejście niż całkowite zaprzestanie ruchu i zaprzestanie angażowania się w rzeczy, które mają dla Ciebie znaczenie. Pozostań pozytywnie nastawiony i tak aktywny, jak to możliwe, i pamiętaj, że LBP ma tendencję do poprawy i ustąpienia z czasem.

3. Dbaj o swoje ogólne samopoczucie

Jak wyjaśniono, na ból może wpływać wiele różnych czynników. Dbanie o ogólne samopoczucie jest zatem dobrym punktem wyjścia do radzenia sobie z LBP i zmniejszenia ryzyka nawrotu poważnych epizodów w przyszłości. Zajmij się stresem, zmartwieniami, lękiem, objawami depresji i innymi obciążeniami emocjonalnymi, które możesz mieć. Zwróć również uwagę na wszelkie potencjalne choroby współistniejące, a także zachowania zdrowotne wykraczające poza aktywność fizyczną, takie jak wzorce snu, dieta, spożywanie alkoholu i/lub nikotyny. Utrzymanie zdrowej masy ciała, unikanie palenia i radzenie sobie z obniżonym nastrojem może pomóc Ci zmniejszyć ryzyko uporczywego LBP.

4. Zarządzaj swoją aktywnością fizyczną

W leczeniu nieswoistego bólu pleców trwającego krócej niż 3 miesiące, podstawowymi metodami leczenia są metody niefarmakologiczne, takie jak porady, edukacja i aktywność fizyczna.

Leżenie w łóżku i unikanie aktywności nie przyniesie żadnych korzyści i może opóźnić powrót do zdrowia, więc staraj się pozostać aktywnym. Nie ma mocnych dowodów na poparcie jakiegokolwiek konkretnego rodzaju ćwiczeń lub aktywności, które byłyby bardziej korzystne niż inne. Oznacza to, że powinieneś być aktywny w sposób, który sprawia ci przyjemność i sprawia ci przyjemność, ponieważ pomoże ci to utrzymać rutynę w dłuższej perspektywie.

Naprawdę niska aktywność fizyczna, jak również wysoki i intensywny poziom aktywności zostały powiązane z LBP. Dlatego jeśli jesteś już naprawdę aktywny i być może często uprawiasz sport, możesz potrzebować przez jakiś czas zachować tempo, a następnie stopniowo wracać do swojego zwykłego poziomu, upewniając się, że masz wystarczająco dużo czasu na odpoczynek i regenerację.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy ból jest najsilniejszy, ruch najlepiej jest wykonywać w krótkich seriach w ciągu dnia. Nie jest to niebezpieczne, jeśli ruch wywołuje pewien możliwy do opanowania i tymczasowy ból i dyskomfort. Możesz zacząć od chodzenia i delikatnych, mniej bolesnych ruchów, które pobudzają krążenie krwi i pewność siebie, a następnie stopniowo zwiększać aktywność z czasem. Unikanie lub obawianie się ruchu z powodu bólu może opóźnić powrót do zdrowia.

Jeśli czujesz się spięty lub niespokojny lub zauważysz, że ból negatywnie wpływa na Twój nastrój, pomocne może być wypróbowanie ćwiczeń relaksacyjnych, medytacji i oddechowych. Fizjoterapeuta lub inny pracownik służby zdrowia może Ci pomóc, jeśli nie jesteś pewien, co możesz zrobić.

5. Leki i okłady termiczne łagodzące ból

W celu krótkotrwałego złagodzenia bólu przydatne mogą być ciepłe okłady. Lekarz może również zasugerować przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), aby pomóc Ci przetrwać początkowy okres. Celem jest pomoc w utrzymaniu aktywności, co przyspieszy Twój powrót do zdrowia. Zaleca się przyjmowanie leków przez możliwie najkrótszy czas i w najniższej skutecznej dawce. Skonsultuj się najpierw z lekarzem, jeśli nie jesteś pewien, jakie leki możesz przyjmować, ponieważ na przykład środki przeciwbólowe (np. paracetamol) nie są zalecane w celu złagodzenia bólu w dolnej części pleców, chyba że są stosowane w połączeniu z innymi lekami.

6. Unikaj niewłaściwych, nieskutecznych metod leczenia

Jeśli ból w dolnej części pleców trwa krócej niż 3 miesiące, nie zaleca się stosowania ortez i gorsetów, ani na przykład elektroterapii, trakcji, akupunktury, terapii biopola, suchego igłowania, terapii craniosacralnej ani zastrzyków.

Jeżeli chcesz znaleźć i pozbyć się źródła twojego problemu, sugeruję terapie P-Dtr która jest w stanie usunąć i zresetować złe informacje z receptorów bólu.



Jesteś najważniejszą osobą w radzeniu sobie z LBP, ale jeśli czujesz się zaniepokojony i/lub zmartwiony lub uważasz, że potrzebujesz wsparcia, zawsze skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby uzyskać poradę i dalsze wsparcie.



Dbanie o swoje ogólne samopoczucie stanowi istotny element radzenia sobie z LBP i ograniczania ryzyka nawrotu poważnych epizodów w przyszłości.



Staraj się zachować pozytywne nastawienie i bądź aktywny, pamiętaj, że LBP ma tendencję do ustępowania z czasem i przy Twoim udziale.

Ogłoszenie.

Należy pilnie udać się do lekarza, jeśli cierpisz na ból w dolnej części pleców i rozwinie się którykolwiek z poniższych objawów:

- Drętwienie lub utrata czucia w okolicy narządów płciowych, tj. „okolicy siodłowej”
- Problemy lub niemożność kontrolowania funkcji pęcherza moczowego/jelit -
- Trudności w unoszeniu stopy z powodu osłabienia

